До прийому психіатра

Лада, 34 роки · 02.10.2026 · Мої нотатки для прийому

Коротко про ситуацію

Останні два роки Лада майже постійно хворіє; останні місяці, особливо останній, стали важчими. Зараз найбільше турбують **тривога, поганий сон, біль, втома та дуже мале харчування**. Хочу зрозуміти, що змінилося порівняно з її звичайним станом, і допомогти з тривогою та сном, не посилюючи денну втому. Мене також хвилює вплив лікування на лібідо та ризик кровотеч з огляду на її історію.

Тривога та її звичайний стан

Тривожність описує як давню, ще з дитинства. Водночас каже, що у спокійний день, коли все добре й нічого не потрібно робити, не дуже тривожиться. Є постійне відчуття, що треба щось робити. Сьогодні пояснила це саме як **страх: «Якщо я нічого не робитиму, все зруйнується, погіршиться або зі мною станеться щось погане»**. Пов’язує це з вимогами й залякуванням батьків у дитинстві. Навіть розповідаючи про цей страх, відчула фізичний дискомфорт у ділянці серця; точно описати відчуття їй важко.

Зараз боїться подальшого погіршення здоров’я, хвилюється через роботу й зобов’язання перед клієнтами. Має невеликий бізнес, зараз не працює. Описує епізоди тривоги, не обов’язково панічні атаки. **01.10 зранку тривога довго не минала без зрозумілої їй причини.**

Як змінювався стан

Згадує **один-два відносно щасливі місяці влітку**, коли здоров’я дало перепочинок. Приблизно в середині літа після сварки з матір’ю почалося поступове погіршення. Особливо важко стало в середині серпня під час іншої стресової ситуації. Спочатку я оцінював тривалість погіршення настрою приблизно у шість тижнів, але точний початок встановити важко.

Їй складно описувати свої відчуття, а мені - відрізняти її звичайний стан від нових змін. Учора відповідали на опитувальники, але деякі запитання вона могла розуміти по-своєму. Хотілося б уточнити їх на конкретних прикладах і врахувати фізичну хворобу, стрес, недосипання та мале харчування при оцінці настрою.

Сон, біль, апетит і втома

Давно погано спить; зараз важко заснути, сон переривчастий, рано прокидається. Бували погані сни, після яких не могла заснути. Прокидається від болю; коли я ночував поруч, будила мене через біль. Парацетамол допомагав мало.

Апетит давно поганий, а останнім часом **майже або зовсім відсутній**, їсть дуже мало. З дитинства болить живіт після їжі; часто їсть лише раз на день. Під час і після нападів астми описує поширений м’язовий біль, зокрема в ногах; періодично болить спина.

Бували періоди дуже сильної сонливості. Наприкінці вересня після їжі засинала на 1-2 години. Під час окремих епізодів помічав сповільнення мови й думок, нестійкість при ходьбі. **Важливо не посилити ці проблеми лікуванням.**

Здоров’я та ліки

Лада · 02.10.2026

Важливі фізичні проблеми

Багаторічна астма, сезонна алергія, щорічні госпіталізації через астму. За останній місяць були тяжкі реакції з набряком губ, язика або горла, викликами швидкої та адреналіном. Наприкінці серпня перенесла COVID. У березні була госпіталізація через кишкову непрохідність без операції. У 2024-2026 роках - кілька гінекологічних операцій, зокрема через розрив кісти з сильною кровотечею.

Є нестача заліза й порушення функції щитоподібної залози: **19.09 ТТГ 5,833 мкМО/мл, вільний Т4 0,54 нг/дл при нормі 0,61-1,47**. Зріст 170 см, вага 30.09 - 61 кг. Останніми тижнями були набряки та значні коливання ваги.

Попередні спроби та консультація 01.10

Раніше **Триттіко (тразодон) 50 мг перед сном** приймала лише чотири дні, потім припинила. **Гідазепам** близько місяця тому ніби допоміг на кілька днів; нещодавно знову спробувала, але каже, що тепер він посилює тривогу й втому та не допомагає.

01.10 психіатр спочатку запропонувала есциталопрам; після обговорення кровотеч і лібідо змінила його на тразодон. У письмовому призначенні: **тразодон 50 мг на ніч із поступовим підвищенням; прегабалін 75 мг увечері; гідроксизин 25 мг на ніч**. Купив гідроксизин 25 мг; ми обговорювали пробу половини таблетки, але фактичний початок нових препаратів поки не можу підтвердити.

Ранок

Ніксар (біластин) 20 мг, за потреби до 40 мг на добу. Призначені також **Еутирокс 37,5 мкг** перед сніданком, **Проксіум 40 мг** і **Дуспаталін Ретард 200 мг**. Повний фактичний ранковий прийом я поки не можу підтвердити.

Вечір та інгалятор

Дуспаталін Ретард 200 мг - 1 капсула; Проксіум 40 мг - 1 таблетка; Флебодіа 600 мг - 1 таблетка; Жастінда (дієногест 2 мг + етинілестрадіол 0,03 мг); **Аваміс 27,5 мкг/розпилення** в ніс.

Симбікорт Турбухалер 160/4,5 мкг призначений по одному вдиху двічі на день і додатково за потреби; я не впевнений, наскільки регулярно вона ним користується.

Нещодавно

Медрол припинила 28.09 після поступового зниження дози. До цього кілька тижнів були Медрол і неодноразово дексаметазон, зокрема під час невідкладної допомоги. Парацетамол давали через біль, із невеликим полегшенням.